

CAPÍTULO 7.4

Hipotiroidismo

PERFIL EUNACOM 1.03.2.002

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Hipotiroidismo

Clínica

TABLA 7.4.1: SISTEMA VS SÍNTOMAS	
SISTEMA	SÍNTOMAS
General	Astenia, adinamia, intolerancia al frío
Piel	Piel seca, caída de la cola de las cejas
Digestivo	Constipación
Cardiovascular	Bradicardia (en casos severos)
Neurológico	Bradipsiquia, pseudodemencia (adulto mayor)
Musculoesquelético	Hipotonía, mialgias, ↑ CK
Laboral	Hipotermia (severo)

Alteraciones en Laboratorio

- **Anemia:** Generalidades|Anemia macrocítica (↑ VCM)
- **Hiponatremia** (VEC normal)
- Hiperbilirrubinemia indirecta (icteria tardía en neonato)
- **Dislipidemia** (↑ colesterol, ± ↑ triglicéridos)
- ↑ CK

Diagnóstico

- **Screening:** TSH sola (enfermedad frecuente → tamizaje en adulto mayor y mujer)
- **Confirmación:** TSH + T4 libre

TABLA 7.4.2: TSH VS T4 LIBRE		
TSH	T4 LIBRE	TIPO
↑	↓	Primario (ej.: Hashimoto)
↓	↓	Secundario (hipofisario) → necesita RNM

Tratamiento

- **Fármaco:** Levotiroxina (T4)
- **Dosis inicio:** 1,6 mcg/kg/día (ej.: ~100 mcg en 60 kg)
- **Excepciones:** cardiopatas y > 60-65 años → iniciar con 25-50 mcg/día y subir de a poco

Seguimiento

TABLA 7.4.3: PARÁMETRO VS OBJETIVO		
PARÁMETRO	OBJETIVO	CONTROL
TSH	0,4 – 4 mUI/L	Cada 6 semanas hasta estabilizar, luego cada 3-6 meses
Si TSH < 0,4	Bajar dosis de levotiroxina	
Si TSH > 4	Subir dosis de levotiroxina	

Excepciones del objetivo TSH: - **Adulto mayor > 75 años:** TSH objetivo = **3 – 6** (riesgo de arritmia) - **Embarazo:** TSH objetivo = **0,4 – 2,5** (más estricto) - **Hipotiroidismo secundario:** no usar TSH para seguimiento → usar **T4 libre**

EUNACOM CRITERIOS
En hipotiroidismo secundario (hipofisario): la TSH **no sirve para seguimiento**. Se sigue con T4 libre.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Mujer de 42 años consulta por astenia progresiva de 6 meses, intolerancia al frío, constipación, aumento de 5 kg de peso y piel seca. Al examen: tiroides discretamente aumentada de tamaño, firme e indolora. TSH: 18.5 mUI/L, T4 libre: 0.4 ng/dL. Anticuerpos anti-TPO marcadamente positivos."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Hipotiroidismo Primario por Tiroiditis Autoinmune (Enfermedad de Hashimoto): causa más frecuente en zonas yodosuficientes. Caracterizado por TSH elevada con T4L baja y anti-TPO (+). Tratamiento: Levotiroxina oral 1.6 mcg/kg/día tomada en ayunas 30-60 minutos antes del desayuno. Control de TSH a las 6-8 semanas para ajuste de dosis.

- PUNTOS CLAVE DESTACADOS**
- Clínica: astenia, intolerancia al frío, constipación, piel seca, bradipsiquia. Laboratorio: anemia macrocítica, hiponatremia (VEC normal), hiperbilirrubinemia indirecta, dislipidemia, CK elevada.
 - Screening con TSH. Confirmación con TSH + T4 libre. Primario: TSH alta + T4 baja. Secundario: TSH baja + T4 baja.
 - Tratamiento: levotiroxina 1,6 µg/kg. Ajustar por TSH hasta rango 0,4-4 mU/L. Control cada 6 semanas.
 - Cardiópatas y adultos mayores: iniciar con dosis bajas (25-50 µg) para evitar arritmias.
 - Adultos >75 años: objetivo TSH 3-6. Embarazo: objetivo TSH 0,4-2,5.
 - Hipotiroidismo secundario se sigue con T4 libre (no TSH).
 - Hipotiroidismo subclínico: no se trata salvo TSH >10 o excepciones (embarazo, demencia, dislipidemia, depresión).

FIGURA 7.4: ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE HIPOTIROIDISMO



EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (HIPOTIROIDISMO)

PREGUNTA 1

Mujer de 55 años con hipotiroidismo primario en tratamiento con levotiroxina. Control muestra TSH 0,2 mU/L. ¿Cuál es la conducta?

- A)** Mantener la dosis actual
- B)** Aumentar la dosis de levotiroxina
- C)** Disminuir la dosis de levotiroxina
- D)** Suspender levotiroxina definitivamente
- E)** Agregar T3 al tratamiento

PREGUNTA 2

Paciente de 80 años con antecedente de cardiopatía isquémica es diagnosticado con hipotiroidismo primario (TSH 25 mU/L). ¿Con qué dosis de levotiroxina se debe iniciar?

- A)** 100 µg/día (dosis plena según peso)
- B)** 200 µg/día
- C)** 25-50 µg/día con aumento gradual
- D)** No tratar por el riesgo cardíaco
- E)** Levotiroxina 1,6 µg/kg + betabloqueador profiláctico

PREGUNTA 3

Embarazada de 10 semanas con hipotiroidismo en tratamiento. TSH de control: 3,5 mU/L. ¿Cuál es la conducta?

- A)** Mantener la dosis, TSH está en rango normal
- B)** Aumentar la dosis de levotiroxina
- C)** Disminuir la dosis de levotiroxina
- D)** Suspender levotiroxina durante el embarazo
- E)** Cambiar a PTU

RESUMEN: HIPOTIROIDISMO

El hipotiroidismo se presenta con astenia, adinamia, intolerancia al frío, constipación, piel seca, bradipsiquia, caída de la cola de las cejas, bradicardia e hipotermia en casos severos, hiporreflexia y alteraciones de laboratorio como anemia macrocítica, hiponatremia con VEC normal, hiperbilirrubinemia indirecta, dislipidemia (hipercolesterolemia) y aumento de CK. El screening se hace con TSH, recomendado en adultos mayores, mujeres y pacientes sintomáticos. Se confirma con TSH + T4 libre. En el primario: TSH alta + T4 libre baja. En el secundario: TSH baja + T4 libre baja (requiere RMN). El tratamiento es con levotiroxina 1,6 µg/kg (aprox. 100 µg en persona de 60 kg), ajustando por TSH cada 6 semanas hasta rango normal (0,4-4 mU/L). Excepciones importantes: en cardiópatas y adultos mayores iniciar con dosis bajas (25-50 µg). En mayores de 75 años el objetivo de TSH es más alto (3-6). En embarazo: TSH objetivo 0,4-2,5. En hipotiroidismo secundario el seguimiento es con T4 libre (no TSH). El hipotiroidismo subclínico generalmente no se trata salvo TSH >10 o excepciones específicas.